12. EL CORAZÓN : DIÁSTOLE Y SÍSTOLE

DURACIÓN : 05:06 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la dinámica esencial de los movimientos sistólicos y diastólicos del corazón, enfatizando su impacto en la energía corporal y las emociones. Aprenderá a observar las orientaciones verticales y horizontales del corazón, lo que puede revelar aspectos cruciales de la salud emocional de sus pacientes. Los conceptos de bucle ventricular y la interacción con otros sistemas orgánicos como el hígado y los pulmones muestran cómo el corazón mantiene una presión reguladora en su entorno fascial. Las técnicas prácticas de evaluación manual del cuero fascial y los movimientos permiten aplicar estas nociones en un entorno terapéutico, al tiempo que revelan la conexión entre el corazón y el diafragma para un buen funcionamiento rítmico y metabólico.

13 - EL CORAZÓN: DIÁSTOLE Y SÍSTOLE

El **corazón** almacena **energía** en un entorno **fascial**, sosteniendo así su **electricidad**, tanto en su fase ascendente como descendente.

Existe una **predominancia innata** en algunas personas, que pueden manifestar una función **sistólica** o **diastólica**. Normalmente se requiere un equilibrio entre estas dos funciones. El corazón repite su movimiento embrionario de manera bastante directa.

MOVIMIENTOS DEL CORAZÓN E IMPLICACIONES EMOCIONALES

Se puede sentir un movimiento específico. Por ejemplo, las personas demasiado orientadas hacia un movimiento de **sístole** a menudo están en búsqueda, pero también pueden agotarse rápidamente. Por el contrario, otras parten de este punto y buscan constantemente un punto de apoyo inferior.

EL LOOPING VENTRICULAR Y LAS FASES CARDÍACAS

El corazón realiza un **looping** característico, donde el sistema **ventricular**, inicialmente superior, se vuelve inferior, con un punto de apoyo crucial entre las **aurículas** y los **ventrículos**.

- **Durante la sístole:**

* El corazón realiza un **ascenso**.

* Realiza un movimiento de **supinación**.

* Tiende a **verticalizarse**.

* Procede a una **destorsión**.

Es en este momento cuando la **aorta** se abre para recibir toda la sangre, provocando una **congestión**.

- **Durante la diástole (descenso):**

* Toda la sangre de la aorta es eyectada al sistema.

A veces es fácil confundir el movimiento sistólico con el movimiento de descenso. La sístole es el momento de la **eyección**. Cuando el corazón desciende, se **vuelve a llenar**.

Cuando se eyecta el volumen, la presión en el sistema del cayado aórtico aumenta. En el momento del descenso, el corazón se llena mientras eyecta la aorta.

ORIENTACIÓN DEL CORAZÓN: VERTICALIZACIÓN VS. HORIZONTALIZACIÓN

¿Tiene la impresión de que el corazón tiende a **verticalizarse** o a **horizontalizarse**? ¿Se verticaliza y asciende, o se horizontaliza y desciende?

PUNTOS DE APOYO PARA LA OBSERVACIÓN

Vamos a tomar tres puntos de apoyo:

1. A nivel del **espacio aórtico** (segundo espacio intercostal).

2. A nivel del **espacio pulmonar**.

3. La **eminencia hipotenar** se apoyará en la punta del corazón.

LOS SISTEMAS INFLUYENTES DEL CORAZÓN

El corazón reacciona en función de dos grandes sistemas que le son muy cercanos y tiende a ayudarlos al máximo:

- El **hígado**
- El **estómago**
- Los **pulmones**
- Los **riñones**

Siempre busca mantener esta presión en su entorno. El corazón es un **regulador de volumen**. Hay que considerar el corazón como una gran arteria que se prolonga con la aorta, como un **pulpo**.

MOVIMIENTOS DE SUPINACIÓN Y PRONACIÓN

Tendremos un movimiento de **supinación**, luego un movimiento de **pronación**.

EVALUACIÓN MANUAL Y REACTIVIDAD FASCIAL

Vamos a observar el entorno y cómo está dispuesto. Luego, colocaremos las manos a nivel del hígado y observaremos su reacción en un plano **fascial**.

La aorta, si la observan bien a nivel anatómico, en realidad parte bastante hacia atrás, lo que la hace difícil de visualizar. Sin embargo, comparte un entorno fascial común con los **bronquios** y el **esófago**, que se insertan a nivel de una vértebra a menudo en adaptación.

LAS ZONAS RÍTMICAS Y LA RELACIÓN DIAFRAGMÁTICA

Existen:

- Una zona **neurosensorial**.
- Una zona **rítmica**.
- Una zona **metabólica**.
- Una zona **urogenital**.

Para un buen movimiento, el corazón debe tener una buena relación con el **diafragma**. Existe una relación directa a través de la continuidad fascial del cayado y la aorta.

Recuerden el paso muy profundo de la aorta, donde los **pilares diafragmáticos** se insertan a ambos lados. Para trabajar el corazón, es esencial que el diafragma esté **abierto** y **flexible**. No olviden el otro paso importante a nivel del esófago.

APLICACIÓN PRÁCTICA: SEGUIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS FASCIALES

Hemos estudiado el **fulcro embrionario pre-pattern** que se posiciona a nivel de la línea primitiva, a nivel del cóccix, con el punto de llegada.

Ahora, coloquemos la mano a nivel del corazón y dejémosla seguir el movimiento fascial. El tejido, si están atentos, les indicará si el corazón se inclina más hacia la sístole o hacia la diástole.

¿Es mi hígado el que reacciona? ¿Es con respecto a mi estómago? ¿O es con respecto a mis riñones? (Tres niveles). Luego, observaremos si esto puede reequilibrarse con respecto a esta observación.